

La pyéloplastie est une chirurgie qui corrige un rétrécissement à la jonction pyélo-urétérale (JPU) — l'endroit où le rein se draine dans l'uretère, le tube qui achemine l'urine vers la vessie. Ce rétrécissement retient l'urine et peut causer douleur, infections ou tension sur le rein. La pyéloplastie retire le segment bloqué et reconstruit une connexion large et libre — la réparation la plus durable, avec un taux de succès supérieur à 90 %.

À propos de cette intervention

En haut de l'uretère, là où il rejoint la poche collectrice du rein (le **bassin**et), un rétrécissement peut freiner le drainage de l'urine. Parfois, un **vaisseau sanguin** voisin appuie sur la jonction. C'est ce qu'on appelle un **syndrome de la jonction pyélo-urétérale**. Lors de la pyéloplastie, votre chirurgien :

- Retire le segment rétréci
- Relie l'uretère sain au bassin
et en formant une **connexion large en entonnoir**- Laisse une **sonde JJ** (endoprothèse) souple à l'intérieur pour maintenir la jonction ouverte le temps de la cicatrisation

L'intervention se réalise le plus souvent par **chirurgie robotique ou laparoscopique** à travers quelques petites incisions ; parfois par une incision ouverte.

Est-ce sans danger ?

La pyéloplastie est une intervention bien établie et très efficace, avec un succès durable supérieur à 90 %. Comme toute chirurgie, elle comporte des risques : saignement, infection ou fuite urinaire temporaire (généralement gérée par la sonde JJ et un drain). La récurrence du rétrécissement est rare et peut habituellement être traitée.

COMPRENDRE LES TERMES

Rein

L'organe qui filtre votre sang et produit l'urine.

Uretère

Le tube qui achemine l'urine du rein vers la vessie.

JPU

La jonction pyélo-urétérale — là où le rein rejoint l'uretère ; le point bloqué.

Bassin

La poche en entonnoir où l'urine s'accumule avant d'entrer dans l'uretère.

Sonde JJ

Un tube souple interne (« double J ») qui maintient la réparation ouverte le temps de la cicatrisation.

Vaisseau croiseur

Un vaisseau sanguin qui peut comprimer la jonction et provoquer le blocage.

Hydronéphrose

Dilatation du rein causée par l'accumulation d'urine en amont du blocage.

Robotique / laparoscopique

Chirurgie mini-invasive réalisée par quelques petites incisions.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se déroule sous anesthésie générale : vous ne ressentez rien pendant l'intervention. Après, attendez-vous à une sensibilité au niveau des petites incisions, ainsi que parfois une gêne à l'épaule ou au ventre due au gaz utilisé en chirurgie mini-invasive. La sonde JJ peut provoquer quelques urgences mictionnelles ou une légère douleur au flanc en urinant. La plupart des patients restent 1 à 2 nuits ; l'intervention dure souvent 2 à 3 heures.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale** — suivez toutes les instructions chirurgicales (jeûne et médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Un **examen d'urine** vérifie l'absence d'infection — une infection doit être traitée avant l'opération.
- Prévoyez une **sonde JJ interne pendant environ 4 à 6 semaines** et organisez votre retour à domicile accompagné.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection urinaire en cours
- Avez subi une chirurgie rénale ou abdominale antérieure

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi(e) sous anesthésie et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Le chirurgien réalise quelques petites incisions (ou une incision ouverte) et expose la jonction bloquée.
- 3 Le segment rétréci est retiré et le bassinet est remodelé.
- 4 L'uretère sain est cousu au bassinet en entonnoir sur une sonde JJ ; un petit drain peut être laissé en place, puis les incisions sont fermées.

Après la chirurgie

- Vous rentrez généralement à domicile en **un à deux jours**.
- La **sonde JJ reste en place environ 4 à 6 semaines**, puis est retirée lors d'une courte cystoscopie en consultation.
- Les symptômes liés à la sonde — urgences, légère douleur au flanc en urinant, urines rosées — sont **normaux**.
- **Évitez les efforts lourds** pendant quelques semaines et buvez abondamment.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Une douleur au flanc ou au ventre sévère ou croissante
- Un saignement important ou des caillots dans les urines
- Une impossibilité d'uriner, ou des nausées et vomissements persistants
- Une rougeur, douleur ou écoulement croissant au niveau d'une incision

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La pyéloplastie supprime le blocage à la jonction rein-uretère et reconstruit une connexion large — la réparation la plus durable, réalisée le plus souvent par petites incisions.
2. Pour vous préparer : consignes de jeûne et de médicaments, traitement de toute infection, sonde JJ pendant ~4 à 6 semaines, et un accompagnant.
3. La sonde peut causer urgences ou gêne au flanc jusqu'à son retrait en consultation.